

Viêm Bàng Quang Kẽ / Hội Chứng Đau Bàng Quang

Thông tin cho bệnh nhân · Đau và tiểu gấp mạn tính không do nhiễm trùng

WARWIKI

Viêm bàng quang kẽ, còn gọi là hội chứng đau bàng quang (IC/BPS), là tình trạng mạn tính gây **đau, áp lực hoặc khó chịu ở bàng quang hay vùng chậu**, kèm theo tiểu nhiều lần hoặc tiểu gấp — **không do nhiễm trùng**. Cảm giác khó chịu thường tăng khi bàng quang đầy và giảm sau khi đi tiểu. Tình trạng này có thể kiểm soát tốt dù không có cách chữa trị dứt điểm.

Về tình trạng này

IC/BPS không phải nhiễm trùng và không lây. Triệu chứng khác nhau ở mỗi người, thường có **đợt bùng phát** (nặng hơn) xen kẽ các giai đoạn lắng dịu. Biểu hiện thường gặp:

- Đau, áp lực hoặc khó chịu ở bàng quang hay vùng chậu
- Tiểu nhiều lần và/hoặc tiểu gấp, cả ngày lẫn đêm
- Khó chịu **tăng khi bàng quang đầy** và giảm sau khi đi tiểu
- Đợt bùng phát có thể do thức ăn, căng thẳng hoặc chu kỳ kinh nguyệt

Nguyên nhân

Nguyên nhân chính xác chưa được biết rõ. Nhiều khả năng là do sự kết hợp của lớp niêm mạc bàng quang nhạy cảm hoặc bị kích thích, dây thần kinh quá nhạy, và (thường gặp) **cơ sàn chậu căng cứng, tăng hoạt**. Vì có nhiều yếu tố, điều trị thường kết hợp nhiều phương pháp.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

IC/BPS

Viêm bàng quang kẽ / hội chứng đau bàng quang — đau và tiểu gấp, không do nhiễm trùng.

Đợt bùng phát

Giai đoạn triệu chứng nặng hơn, thường do thức ăn hoặc căng thẳng.

Chẩn đoán loại trừ

Được chẩn đoán sau khi đã loại trừ các nguyên nhân khác (như nhiễm trùng).

Vật lý trị liệu sàn chậu

Liệu pháp giúp giải phóng cơ sàn chậu bị căng cứng.

Bơm thuốc vào bàng quang

Thuốc làm dịu được đưa vào bàng quang qua ống thông mỏng.

Tổn thương Hunner

Vùng tổn thương đặc biệt trên thành bàng quang, có thể điều trị trực tiếp.

Nội soi bàng quang

Quan sát bên trong bàng quang bằng camera nhỏ.

CÓ TỰ KHỎI KHÔNG? IC/BPS thường là tình trạng lâu dài, nhưng hầu hết người bệnh đều có thể cải thiện rõ rệt nhờ kết hợp điều trị và nhận biết các yếu tố kích hoạt. Mục tiêu là giảm tần suất và mức độ đợt bùng phát để sống bình thường — thường cần thử và điều chỉnh, hãy kiên nhẫn với quá trình này.

Chẩn đoán như thế nào

Không có một xét nghiệm duy nhất. Bác sĩ chẩn đoán dựa trên triệu chứng sau khi loại trừ các nguyên nhân khác:

- **Xét nghiệm nước tiểu** để loại trừ nhiễm trùng hoặc tiểu ra máu
- Khai thác triệu chứng và **nhật ký bàng quang**
- Đôi khi **nội soi bàng quang** để tìm tổn thương Hunner

Điều trị như thế nào (từng bước)

- 1 **Tự chăm sóc** — xác định **thức ăn kích hoạt**, kiểm soát căng thẳng và giấc ngủ, tập luyện bàng quang nhẹ nhàng.
- 2 **Vật lý trị liệu sàn chậu** — giải phóng cơ căng (lưu ý: tập Kegel mạnh có thể làm nặng thêm).
- 3 **Thuốc** — thuốc uống và **bơm thuốc vào bàng quang** để làm dịu.
- 4 **Điều trị chuyên sâu** — xử lý tổn thương Hunner hoặc kích thích thần kinh trong các trường hợp khó.

Sống chung với IC/BPS

- Yếu tố kích hoạt thường gặp: **cà phê, trà, rượu, cam quýt, cà chua và thức ăn cay** — thử loại bỏ rồi thêm lại từng thứ để tìm ra của bạn.
- Chuẩn bị **kế hoạch ứng phó đợt bùng phát** (nghỉ ngơi, chườm ấm, uống thêm nước, ăn nhẹ nhàng).
- Căng thẳng và cơ sàn chậu căng cứng làm vòng xoáy xấu đi — vận động nhẹ và thư giãn giúp ích nhiều.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt, ớn lạnh hoặc đau lưng/hông (có thể nhiễm trùng)
- **Tiểu ra máu** mới xuất hiện
- Đợt bùng phát không kiểm soát được hoặc không đi tiểu được

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. IC/BPS là đau bàng quang/vùng chậu kèm tiểu gấp, **không** phải nhiễm trùng — mạn tính nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát.
2. Điều trị kết hợp tự chăm sóc và kiểm soát yếu tố kích hoạt, vật lý trị liệu sàn chậu, thuốc và bơm thuốc bàng quang, cùng điều trị chuyên sâu khi cần.
3. Nhận biết thức ăn và căng thẳng kích hoạt bệnh; lập kế hoạch ứng phó. Tiểu ra máu mới, sốt hoặc đau hông cần được kiểm tra ngay.